

GUÍA RAPIDA DE MANEJO PB980

Descripción de la BDU



Para uso en neonatos, retire la puerta del filtro exhalatorio adulto/pediátrico e instale la puerta exclusiva para el filtro exhalatorio neonatal*

*** Disponible en equipos con configuración neonatal**

Descripción de la GUI



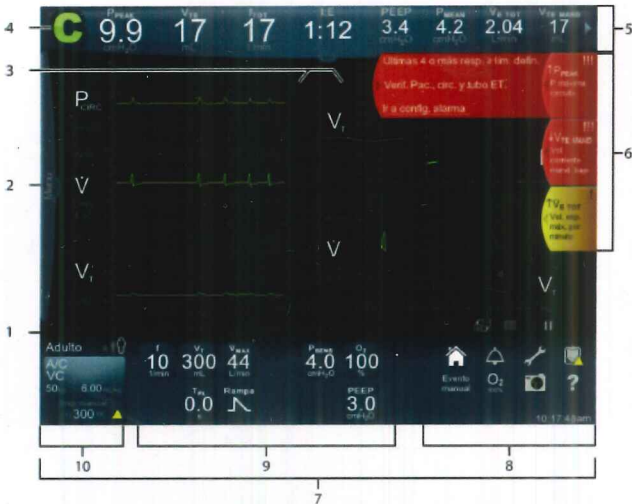
Medtronic

Indicadores GUI

	Botón de configuración del respirador Situado en la esquina inferior izquierda de la GUI. Toque este botón para abrir la pantalla de configuración del respirador.		Tecia de bloqueo de la pantalla - Acciona un bloqueo para prevenir cambios involuntarios de los parámetros del respirador (incluida la función del botón giratorio) mientras la pantalla está bloqueada. El bloqueo de pantalla es útil para limpiar la pantalla táctil. Pulse de nuevo la tecla para desbloquear la pantalla. Utilice también la tecla de bloqueo de la pantalla para restablecer la pantalla táctil de la GUI.
	Indicador del circuito del paciente adulto. Indica el tipo de circuito para adultos probado durante el ATC y en uso.		Tecia de volumen de alarma - Ajusta el volumen de la alarma. El volumen de la alarma no se puede DESACTIVAR.
	Indicador del circuito del paciente pediátrico. Indica el tipo de circuito pediátrico probado durante el ATC y en uso.		Tecia de inspiración manual - En los modos A/C, SIMV y SPONT, administra una respiración manual al paciente de acuerdo con los parámetros de respiración obligatorios actuales. En el modo BiLevel, se pasa de baja presión (PL) a alta presión (PH) (o viceversa). A fin de evitar una acumulación de respiraciones, no se administra la inspiración manual durante la inspiración o durante la fase restringida de espiración, para obtener información sobre la fase restringida de espiración. La tecla de inspiración manual se puede utilizar para administrar respiraciones obligatorias al paciente o para ejecutar una maniobra de pausa inspiratoria en modo SPONT. La tecla de inspiración manual no se puede utilizar para ejecutar una maniobra de pausa espiratoria en modo SPONT.
	Indicador del circuito del paciente neonatal. Indica el tipo de circuito neonatal probado durante el ATC y en uso.		Tecia de pausa inspiratoria - Inicia una pausa inspiratoria que cierra las válvulas inspiratorias y espiratorias y prolonga la fase inspiratoria de una respiración obligatoria con la finalidad de medir la presión inspiratoria final (PI END) para el cálculo de la presión estable (PPL), la distensibilidad estática (CSTAT) y la resistencia estática (RSTAT).
	Icono de inicio. Icono de acceso permanente Toque este icono para cerrar todos los cuadros de diálogo abiertos en la pantalla de la GUI. La pantalla se reinicia y muestra las formas de onda del respirador.		Tecia de pausa espiratoria - Inicia una pausa espiratoria que prolonga la fase espiratoria de la respiración actual a fin de medir la PEEP total (PEEP TOT).
EVENTO MANUAL	Al tocar este texto aparece la pantalla de evento manual, donde se pueden registrar eventos para su visualización en el diseño Tendencia.		Tecia de restablecimiento de alarmas - Elimina las alarmas activas o restablece las alarmas de prioridad alta y cancela una condición activa de audio en pausa. Si hay una alarma activa, se registra un restablecimiento de alarma en el registro de alarmas. Las alarmas ALERTA DISPOSITIVO no se pueden restablecer.
	Icono de alarmas. Icono de acceso permanente. Toque este icono para mostrar la pantalla de parámetros de alarma, que permite modificar los límites de alarma.		Tecia de sonido en pausa - Detiene las alarmas durante 2 minutos. Cancele la función de sonido en pausa tocando el botón Cancelar de la pantalla.
	Icono de registros. Icono de acceso permanente. Toque este icono para mostrar la pantalla de registros, que contiene pestañas para registros de Alarmas, Parámetros, Datos del paciente, Diagnósticos, Estado ATG/ATC Eventos generales y servicios		

Medtronic

Áreas de la Pantalla (GUI)

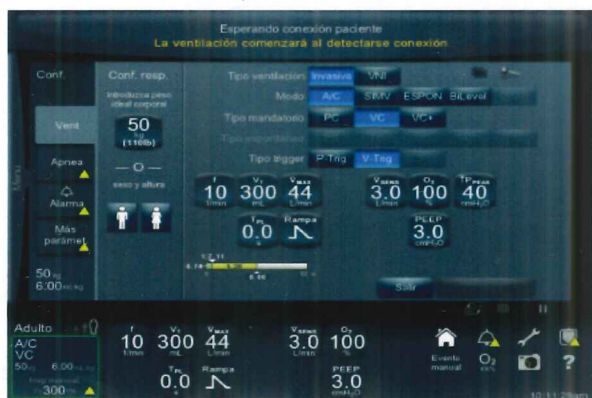


1. **Área de avisos:** situada debajo de las formas de onda. Todos los avisos o mensajes relacionados con los límites flexibles y rígidos se muestran aquí.
2. **Pestaña Menú:** situada en la parte izquierda. Si desliza la pestaña hacia la derecha y toca Config. aparecen las pestañas Vent., Apnea y Alarma.
3. **Área de formas de onda:** situada en la parte central, muestra las diversas formas de onda de la respiración.

4. **Indicador de fase de respiración:** Durante la ventilación normal, en la esquina superior izquierda aparece un indicador de respiración que muestra el tipo de respiración [Asist. (A), Control (C) o Espontánea (S)] que se está administrando al paciente y si se encuentra en la fase inspiratoria o espiratoria.
5. **Banner de datos vitales de paciente:** situado en la parte superior. Muestra los datos monitorizados del paciente y la configuración es personalizable.
6. **Banners de alarma:** situados en la parte derecha. Indican al operador qué alarmas están activas en el color correspondiente a la prioridad (alta: rojo parpadeante, media: amarillo parpadeante y baja: amarillo fijo).
7. **Iconos de acceso permanente:** situados en la parte inferior derecha. En este área se accede a los siguientes iconos: inicio (casa), configurar (llave inglesa), registros (portapapeles), elevar porcentaje de oxígeno (O2) y ayuda (signo de interrogación). Estos iconos siempre están visibles.
8. **Área de acceso permanente:** Compuesta por el área de parámetros actuales y los iconos de acceso permanente. En este área se accede a las variables de configuración del paciente mostradas en estas áreas. Si se toca uno de los iconos aparece el menú correspondiente a la variable.
9. **Área de parámetros actuales:** situada en la parte central inferior. Muestra los parámetros activos actuales del ventilador. Si se toca uno de los botones de los parámetros actuales, aparece un diálogo donde pueden realizarse cambios con el botón giratorio.
10. **Botón Config. Vent.:** situado en la parte inferior izquierda. Al tocar este botón se accede a la pantalla de configuración del ventilador.

Medtronic

Para ventilar a un nuevo paciente



1. Toque Nuevo paciente en la pantalla de la GUI. Aparece la pantalla de parámetros de Nuevo paciente donde puede introducir los parámetros de control de la ventilación.
2. Introduzca el PBW o sexo y altura del paciente (si se selecciona la opción sexo, también aparece la opción de altura).
3. Si la configuración predeterminada del respirador es apropiada para el paciente, toque INICIO para confirmar los parámetros; de lo contrario, toque un parámetro del respirador y gire el control para ajustarlo. Aplique este proceso a todos los parámetros que sea necesario ajustar. Toque Aceptar o Aceptar TODO para confirmar los cambios.
4. Conecte el circuito a la vía aérea del paciente para iniciar la ventilación. Después de iniciarse la ventilación, las formas de onda empiezan a trazarse en los ejes de las formas de onda mostrados.

Para ajustar un parámetro de alarma



1. Toque el control deslizante de las alarmas que se van a cambiar. Todos los parámetros de alarma están disponibles para los parámetros PPEAK, fTOT, VE TOT, VTE MAND, VTE SPON y VTi.
2. Gire el control hacia la derecha para aumentar el valor o hacia la izquierda para disminuirlo.
3. Continúe hasta que todas las alarmas deseadas estén ajustadas, según corresponda.
4. Toque Aceptar TODO para confirmar los parámetros de alarma

ADVERTENCIA:

Antes de iniciar la ventilación y siempre que se realicen cambios en los parámetros del respirador, asegúrese de que los parámetros de alarma son los apropiados para utilizar en el paciente.

Medtronic

Auto Test Corto (SST)

ADVERTENCIA:

Al cambiar cualquier accesorio del circuito del paciente o el circuito propiamente dicho, realice un SST para comprobar que no hay fugas y asegurarse de que en los cálculos del respirador se utilizan la complianza del circuito y los valores de resistencia correctos.

El SST es una prueba que se realiza en cinco minutos y que debe realizarse en cualquiera de las siguientes situaciones:

- Antes de empezar a ventilar a un nuevo paciente
- Al sustituir el circuito del paciente y el filtro espiratorio
- Al conectar un circuito del paciente diferente al respirador
- Al cambiar el tipo de circuito del paciente
- Al instalar un filtro espiratorio esterilizado o nuevo
- Al cambiar el tipo de dispositivo de humidificación
- Al añadir o extraer accesorios en el sistema respiratorio, como un humidificador o un colector de agua.

Para realizar el SST

1. Asegúrese de que el paciente **NO** está conectado al respirador.
2. Para que el respirador no detecte una conexión de paciente, asegúrese de que circuito respiratorio en "Y" no está conectado a un pulmón de prueba ni tapado de modo que pueda aumentar la presión en el circuito en "Y".
3. Encienda el respirador con el interruptor situado en la parte frontal de la BDU, debajo de la pantalla de estado. Al encender el interruptor, el respirador procesa la prueba POST. Asegúrese de que el respirador está funcionando con alimentación de CA. De lo contrario, se pueden producir fallos de prueba del SST.
4. En la pantalla de inicio del respirador, toque SST o el icono Configurar (llave inglesa) que se muestra en el área inferior derecha de la GUI. Aparece el registro del historial de SST y los botones Config. paciente, Proc. prueba fugas y Proc. todas SST.
5. Conecte el circuito del paciente, los filtros, el vial de condensación y todos los accesorios que se van a utilizar durante la ventilación del paciente. Asegúrese de que el circuito en "Y" no está bloqueado.
6. Toque Proc. todas SST para realizar todas las pruebas del SST o toque Proc. prueba fugas para realizar la prueba de fugas SST del circuito de respiración del respirador.
7. Toque Aceptar para continuar o Cancelar para volver a la pantalla anterior.
8. Después de aceptar, toque el botón Tipo de circuito correspondiente al tipo de circuito del paciente utilizado para realizar el SST y para ventilar al paciente (adulto, pediátrico o neonatal).
9. Toque el botón Tipo de humidificación correspondiente al tipo de humidificación utilizada en la ventilación del paciente. Si no se utiliza humidificador, toque HME. Si se utiliza un humidificador, toque Volumen humidificación y gire el control para introducir el volumen.
10. Toque Aceptar para empezar el SST.
11. Siga las indicaciones. Algunas pruebas del SST requieren la intervención del operador y se detendrán de modo indefinido hasta recibir una respuesta.
12. Después de realizar cada prueba, el respirador muestra los resultados. Si alguna de las pruebas falla, el resultado de la prueba aparece en la pantalla y se muestra la opción de repetir la prueba o pasar a la siguiente. Cuando se finalizan todas las pruebas del SST, en la pantalla de estado del SST aparecen los resultados de las pruebas individuales.
13. Para continuar con la configuración de paciente (siempre que el SST no haya detectado una ALERTA o FALLO), toque Aceptar.

Medtronic

Limpieza de las superficies exteriores

Para limpiar la GUI, la BDU o la base del compresor:

Humedezca un paño suave con uno de los desinfectantes que se enumeran o utilice

Sani Cloths (PDI, Inc.).

Consulte la tabla [Agentes de limpieza de superficies](#)

- Limpie la GUI, la BDU y la base del compresor eliminando cualquier tipo de suciedad o de sustancia extraña.
- Seque todos los componentes en profundidad.
- Si fuera necesario, aspire los orificios de ventilación de la GUI y la BDU con un aspirador protegido contra descargas electrostáticas (ESD) para eliminar el polvo.

Precaución:

Manejo EVQ Para evitar dañar el filamento de revestimiento caliente, no introduzca los dedos ni objetos en el puerto central cuando desinfecte el EVQ.

El EVQ contiene el sistema electrónico del sensor de flujo espiratorio, el diafragma de la válvula espiratoria, el precinto del filtro espiratorio y el filtro del sensor de presión. El sistema electrónico del sensor de flujo espiratorio está compuesto por el filamento de revestimiento caliente y el termistor. Al estar protegido por el filtro espiratorio, no es obligatorio ni necesario sustituirlo o desinfectarlo con regularidad. Sin embargo, puede retirarse y desinfectarse según se desee, o si no se supera la prueba cruzada del sensor de flujo del ATC. La vida útil es de 100 ciclos de desinfección.

PARTE	PROCEDIMIENTO/AGENTE LIMPIEZA	COMENTARIOS/PRECAUCIONES
Parte exterior del respirador (incluida la pantalla táctil y el brazo flexible)	Limpie con un paño humedecido con uno de los agentes de limpieza que aparecen en la lista siguiente o equivalente. Utilice un paño húmedo y agua para eliminar los residuos químicos cuando sea necesario. Solución de detergente suave para lavavajillas Alcohol isopropílico (solución al 70 %) Lejía (solución al 10 %) Solución de limpieza de cristales (alcohol isopropílico y amoníaco) Amoníaco (solución al 15 %) Peróxido de hidrógeno (solución al 3 %) Limpiador Formula 409® (Clorox Company) Desinfectante de superficies CaviCide® (Metrex Research Corporation) Germicida Control III® (Maril Products Inc.) Cidex Plus 28 (3,4 %) ; Cidex OPA (0,55 %) Virox (spray o toallitas); (Virox Technologies Inc.) Mr. Muscle Window & Glass (SC Johnson) Sani Cloths (PDI, Inc.) [2-Propanol, isopropanol, alcohol isopropílico]1	No permita que entre líquido o spray en las aberturas del respirador o en las conexiones de cable. No intente esterilizar el respirador exponiéndolo a óxido de etileno (ETO). No utilice aire presurizado para limpiar o secar el respirador, incluidos los orificios de ventilación de la GUI. No sumerja el respirador ni vierta soluciones de limpieza sobre el respirador o en su interior.
Rejillas de ventilación del respirador	Aspire los orificios de la parte trasera de la GUI y la BDU para eliminar el polvo	N/A
EVQ	Antes de la desinfección, póngalo en remojo con detergente enzimático EMpower Dual Enzymatic Solution (Metrex Inc.). Realice una desinfección de alto nivel con desinfectante químico líquido con cualquiera de los siguientes agentes: • Cidex (2,5 %) • Metricide 28 (2,5 %) • Cidex OPA (0,55 %) • Metricide OPA Plus (0,6 %) Siga las instrucciones del fabricante Consulte Desinfección del conjunto del sensor de flujo espiratorio (EVQ) , p. 7-10 para obtener instrucciones específicas. Manual usuario	No deje caer el conjunto del EVQ ni lo maneje bruscamente durante el proceso de desinfección o almacenamiento.
Puerta/Adaptador neonatal	Antes de la desinfección, póngalo en remojo con detergente enzimático EMpower Dual Enzymatic Solution (Metrex Inc.). Realice una desinfección de alto nivel con desinfectante químico líquido con cualquiera de los siguientes agentes: • Cidex (2,5 %) • Metricide 28 (2,5 %) • Cidex OPA (0,55 %) • Metricide OPA Plus (0,6 %)	N/A

Medtronic